Rýchla alebo pomalá korekcia chronickej hyponatriémie? Spor, ktorý sa vracia do klinickej praxe

Autor: Miriam E. Tucker (Medscape); Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Rýchlosť korekcie nie je detail — práve ona rozhoduje o riziku poškodenia mozgu.

Chronická hyponatriémia patrí medzi časté, no klinicky zradné poruchy vnútorného prostredia. Otázka, ako rýchlo bezpečne korigovať sérový sodík, sa opäť dostáva do centra nefrologickej diskusie. Na jarnom klinickom stretnutí National Kidney Foundation v roku 2026 diskutovali dvaja nefrológovia o tom, či by mala byť korekcia chronickej hyponatriémie pomalá, ako odporúčajú súčasné odporúčania, alebo či je pri vybraných pacientoch prijateľný rýchlejší postup.

Súčasný konzervatívny rámec

Aktuálne odporúčania radia pri chronickej hyponatriémii opatrnú korekciu, najmä u pacientov s vysokým rizikom osmotického demyelinizačného syndrómu (ODS). Za rizikových sa považujú predovšetkým pacienti s veľmi nízkou vstupnou natriémiou, približne **105 mmol/l alebo menej**, pacienti s alkoholovou poruchou, malnutríciou, pokročilým ochorením pečene, hypokaliémiou alebo hypofosfatémiou.

Pri týchto pacientoch sa často uvádza horná hranica korekcie **do 8 mmol/l za 24 hodín**. U pacientov s priemerným rizikom sa niektoré odporúčania pohybujú v rozmedzí **10 až 12 mmol/l za deň**.

Podstatou opatrnosti je prevencia osmotického demyelinizačného syndrómu — závažnej neurologickej komplikácie, ktorá môže vzniknúť po príliš rýchlej zmene osmolality mozgového prostredia.

Argument za rýchlejšiu korekciu

Juan Carlos Q. Velez z Ochsner Health v New Orleans zastával stanovisko, že u pacientov s nízkym rizikom ODS môže byť prílišný strach z rýchlejšej korekcie prehnaný. Podľa neho je morbidita symptomatickej hyponatriémie často podceňovaná a dôkazy, že pomalá korekcia znižuje mortalitu alebo spoľahlivo predchádza ODS, nie sú dostatočne silné.

Velez upozornil, že osmotický demyelinizačný syndróm je v novších pozorovacích štúdiách veľmi zriedkavý.

Veľká kanadská analýza z roku 2023, ktorá zahŕňala viac ako 22-tisíc hospitalizácií s hyponatriémiou, našla ODS len približne v **0,05 %** prípadov. Rýchla korekcia bola pritom pomerne častá.

Ďalšia novšia observačná štúdia u pacientov so závažnou hyponatriémiou naznačila, že rýchlejšia korekcia môže byť spojená s nižším rizikom 90-dňovej mortality alebo oneskorených neurologických príhod.

Podľa Veleza sú najzraniteľnejší najmä pacienti s alkoholizmom, malnutríciou, hypokaliémiou a ochorením pečene. Práve u nich má opatrnosť najväčšie opodstatnenie. Naopak, plošne prísne limity môžu podľa neho viesť k nedostatočnej liečbe symptomatickej hyponatriémie a k neprimeranému strachu z účinných liekov vrátane vaptanov.

Argument za opatrnosť

Helbert Rondon Berrios z University of Pittsburgh School of Medicine zastával konzervatívnejší pohľad. Zdôraznil, že limit **8 mmol/l za deň** nebol určený pre všetkých pacientov, ale najmä pre tých s chronickou hyponatriémiou a vysokým rizikom ODS. Nevzťahuje sa rovnako na akútnu hyponatriémiu ani na väčšinu pacientov s natriémiou nad 120 mmol/l.

Podľa Berriosa sú viaceré novšie štúdie metodologicky problematické. Často ide o observačné analýzy, ktoré nemusia dostatočne rozlišovať akútnu a chronickú hyponatriémiu, nemajú systematické zobrazovanie mozgu a pri identifikácii ODS sa spoliehajú na diagnostické kódy alebo rádiologické správy.

Zásadným problémom podľa neho je, že nízke celkové riziko ODS vo veľkých kohortách môže zakrývať podstatne vyššie riziko v najohrozenejších podskupinách. V kanadskej štúdii mala väčšina pacientov natriémiu nad 120 mmol/l. Pri pacientoch so sodíkom **110 mmol/l alebo menej** však incidencia ODS výrazne stúpala.

Berrios tiež upozornil na predbežné údaje zo štúdie PRONATREOUS, ktorá hodnotí pacientov s veľmi závažnou hyponatriémiou. V skupine pacientov s natriémiou **105 mmol/l alebo menej** sa potvrdil ODS zobrazovaním u **4,5 %** a suspektný ODS bez zobrazovacieho potvrdenia u ďalších **14,7 %**. Všetci pacienti s potvrdeným alebo suspektným ODS mali korekciu rýchlejšiu ako 8 mmol/l za deň.

Kde je jadro sporu?

Debata v skutočnosti nestojí na jednoduchej otázke „rýchlo alebo pomaly“. Kľúčové je, **u koho**.

U pacienta s miernejšou hyponatriémiou bez rizikových faktorov môže byť striktné obmedzovanie korekcie menej dôležité. U pacienta s chronickou, hlbokou hyponatriémiou, alkoholizmom, malnutríciou, cirhózou alebo hypokaliémiou môže byť aj relatívne malé prekročenie bezpečnostného limitu klinicky významné.

Problémom observačných štúdií je aj tzv. *confounding by indication*. Pacienti, u ktorých sa sodík upravuje pomaly, môžu byť celkovo chorší — mať cirhózu, srdcové zlyhávanie alebo malignitu. Horšie výsledky potom nemusia byť dôsledkom pomalej korekcie, ale ich základného stavu.

Praktický záver pre klinickú prax

Súčasné údaje naznačujú, že ODS je v celkovej populácii pacientov s hyponatriémiou zriedkavý. To však neznamená, že je zanedbateľný u vysokorizikových pacientov s hlbokou chronickou hyponatriémiou.

Rozumný prístup preto zostáva individualizovaný:

- pri **akútnej symptomatickej hyponatriémii** treba konať rýchlo, najmä pri neurologických príznakoch,
- pri **chronickej hlbokej hyponatriémii** je potrebná opatrnosť,
- osobitnú pozornosť si vyžadujú pacienti s alkoholizmom, malnutríciou, hypokaliémiou a pečeňovým ochorením,
- korekcia sodíka má byť aktívne monitorovaná, pretože nechcené *prestrelovanie* je v praxi časté,
- samotná rýchlosť korekcie sa musí hodnotiť spolu s klinickým kontextom, nie izolovane.

Kým nebudú dostupné presvedčivejšie prospektívne dáta, konzervatívne limity pri vysokorizikových pacientoch zostávajú obhájiteľné. Zároveň však pribúda dôvodov prehodnotiť, či rovnaká opatrnosť musí platiť aj pre pacientov s nízkym rizikom ODS.

Zdroj: Miriam E. Tucker: *Debate: Fast or Slow Correction of Chronic Hyponatremia*, Medscape Medical News, 2026. Dostupné na: medscape.com

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rychla-alebo-pomala-korekcia-chronickej-hyponatriemie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.